

Vaginal Prolapse Repair gamit ang Mesh / Biological Graft

Impormasyon para sa Pasyente · Pagpapatibay ng pagbaba ng organ (prolapse repair) gamit ang karagdagang materyales **WARWIKI**

Ang ilang vaginal prolapse repair ay pinapatibay ng **graft** — karagdagang materyales na inilalagay kung saan mahina ang inyong sariling tisyu. Ang materyales ay maaaring **biological graft** o, sa ilang pagkakataon, mesh. Ipinaliwanag ng sheet na ito ang mga pagpipilian nang tapat, kasama ang kasaysayan ng kaligtasan ng vaginal mesh, para makapagpasya kayo nang may kaalaman kasama ang inyong siruhano.

Tungkol sa Prosedurang Ito

Sa pamamagitan ng hiwa sa dingding ng puki (vagina), iniaayos ang mahinang dingding at inilalagay ang graft para dagdag na lakas at mabawasan ang tsansa ng pagbabalik ng prolapse. Kasama sa mga materyales:

- **Biological graft** — mula sa donated na tisyu ng tao o hayop; nasisisip ito ng katawan habang gumagaling ang inyong sariling tisyu.
- **Synthetic mesh** — permanenteng materyales; ginagamit nang **piling-pili** at may maingat na pagpapayo.

Mahahalagang Paalala sa Kaligtasan

Ang transvaginal **synthetic mesh** para sa prolapse ay naging paksa ng mga babala ng **FDA** at hindi na ibinebenta para sa layuning ito sa U.S. dahil sa mga panganib tulad ng mesh exposure at sakit. Ngayon, karaniwang iniaayos ang prolapse gamit ang **sariling (native) tisyu** o biological graft; ang abdominal mesh (tulad ng sa sacrocolpopexy) ay nananatiling hiwalay at mabuting pagpipilian. Ipaliwanag ng inyong siruhano kung anong materyales ang planong gamitin at kung bakit.

MGA TERMINO

Prolapse

Pagbaba ng mga organ sa pelvis na nagdudulot ng bukol o presyon.

Graft

Karagdagang materyales ng suporta na inilalagay sa panahon ng pagaayos.

Biological graft

Materyales na mula sa tisyu na nasisisip ng katawan sa paglipas ng panahon.

Synthetic mesh

Permanenteng materyales; limitado ang gamit para sa transvaginal prolapse.

Native-tissue repair

Pagaayos gamit lamang ang sariling tisyu, walang graft.

Mesh exposure

Kapag ang kaunting mesh ay naging nakikita o nararamdaman; maaaring magdulot ng sakit o discharge.

DAPAT BA AKONG MAG-ALALA SA MESH? Makatwirang tanong. Ang mga problemang naging dahilan ng mga babala ay partikular sa **transvaginal synthetic mesh para sa prolapse**. Ang native-tissue repair, biological grafts, at abdominal mesh ay may iba't ibang, maayos na napag-araling rekord ng kaligtasan. Mahalagang maunawaan kung ano mismo ang planong gamitin ng inyong siruhano at kung bakit — magtanong.

Mga Tanong na Dapat Itanong sa Inyong Siruhano

- **Anong materyales** ang gagamitin — native tissue, biological graft, o synthetic mesh — at bakit para sa akin?
- Ano ang mga **partikular na panganib**, kasama ang mesh exposure o sakit habang nakikipagtulungan?
- Ano ang aking mga **alternatibo** (native-tissue repair, sacrocolpopexy, isang pessary)?
- Gaano kataas ang tsansa na **bumalik ang prolapse** sa bawat pagpipilian?

Paano Maghanda

- Sundin ang mga tagubilin sa **anesthesia** (pag-aayuno, paghinto ng blood thinners ayon sa utos).
- Huwag manigarilyo; maghanda ng sasakyan at tulong sa bahay.
- Maghanda para sa magaan na gawain at pahinga ng pelvis sa loob ng ilang linggo.

Pagkatapos ng Operasyon

- Normal ang kaunting pagdurugo at discharge sa loob ng ilang linggo.
- **Iwasang mag-angat ng mabigat, mag-strain, at makipagtulungan nang mga 6 na linggo.**
- Palambutin ang dumi; unti-unting bumalik sa aktibidad.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- Lagnat o panginig, o matinding pagdurugo
- **Hindi makaihi**, o lumalalang sakit
- Mamaya: **sakit habang nakikipagtulungan**, kakaibang discharge, o ang inyong kasama ay nakakaramdam ng kung ano (posibleng mesh exposure)

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang graft ay nagdaragdag ng lakas sa vaginal prolapse repair — ang biological grafts ay nasisipsip sa paglipas ng panahon; ang synthetic mesh ay permanente at ginagamit nang piling-pili.
2. Ang transvaginal mesh para sa prolapse ay may babala ng FDA; ang native-tissue repair at biological grafts ay karaniwan, at ang abdominal mesh ay hiwalay na pagpipilian.
3. Itanong kung anong materyales ang planong gamitin at bakit. Iulat ang sakit habang nakikipagtulungan o kakaibang discharge sa bandang huli.